

MEDCARE

Roadmap di sviluppo — verticale Odontoiatria

Piano di realizzazione del primo verticale, sopra un core trasversale

Questo documento descrive lo sviluppo del gestionale per studi odontoiatrici. L'impianto resta a due strati: un core trasversale — comune a qualsiasi professione sanitaria e scritto una volta sola — su cui si innesta il verticale clinico odontoiatrico. Sviluppare ora l'odontoiatria con questa separazione significa che il core sarà riusabile quando in futuro si aggiungeranno altre professioni, senza riscriverlo.

VERTICALE ODONTOIATRIA

cartella clinica · odontogramma · piani di cura e preventivi · AI clinica dentale

si innesta su ↓

CORE TRASVERSALE

anagrafica · agenda · fatturazione (Sistema TS / SdI) · consensi e privacy · CRM e comunicazioni · recall · KPI · portale paziente
scritto una volta sola — riusabile per future professioni sanitarie

Nota operativa: in questa fase si costruisce il verticale odontoiatrico come prodotto completo. Il core va progettato con confini puliti (parte clinica separabile), ma senza costruire meccanismi per specialità che non esistono ancora — l'astrazione si limita a “non incastrare l'odontoiatria dentro il core”.

FASE 1 · MVP operativo

Il core trasversale + il primo verticale clinico

CORE

- **Fondamenta tecniche** — multi-tenant, autenticazione, ruoli e permessi (RBAC), audit log, e l'astrazione della specialità (il core non “sa” di odontoiatria).
- **Anagrafica paziente** — dati, contatti, codice fiscale, fonte di provenienza. L'entità centrale a cui tutto si aggancia.
- **Consensi e privacy** — consensi per finalità separate, storicizzati e revocabili (GDPR, dati sanitari art. 9).
- **Agenda come hub centrale** — multi-poltrona/multi-operatore. Un clic sull'appuntamento apre cartella, piano di cura, contabilità e storico senza cambiare schermata.
- **Fatturazione** — emissione documenti, Sistema TS con pre-verifica, fattura elettronica SdI, conservazione a norma.

VERTICALE ODONTOIATRICO

- **Cartella clinica + odontogramma** — anamnesi, diario clinico, odontogramma interattivo, immagini/radiografie. Dato clinico criptato.
- **Preventivi e piani di cura** — dall'odontogramma, con listini e sconti, e tracciamento dell'accettazione (quanti preventivi diventano cure).

SMART DAL GIORNO UNO

- **WhatsApp anti no-show + UX** — promemoria con conferma/disdetta in un tap; layout adattivo per ruolo; scheda paziente unificata a pannelli.

FASE 2 · Relazione e fidelizzazione

Il motore economico — tutto core

- **Recall e reattivazione** — regole configurabili, alert visite periodiche e reattivazione automatica dei pazienti “dormienti” e dei piani non completati.
- **CRM multicanale** — WhatsApp, email, SMS con storico, più segmentazione: sorgente paziente, tag, referral.
- **AI per le comunicazioni** — genera i testi di promemoria, richiami e mail di accompagnamento al preventivo. Il professionista rivede, non scrive da zero.
 - › **Nota privacy** — *all'AI va solo il template/parametri generici, i dati identificativi del paziente sono inseriti localmente e non escono. Nodo leggero: si può partire senza risolvere prima un grande tema privacy.*
- **Portale paziente e prenotazione online** — prenotazione 24/7 con slot suggeriti in base alla disponibilità reale, accesso a documenti e firma consensi.

FASE 3 · Direzione e organizzazione

Controllo, crescita, team — core

- **Dashboard KPI** — marginalità per prestazione e insight, non solo numeri (“i no-show sono cresciuti del 12%”).
- **Marketing e lead** — campagne social/Google e gestione lead in pipeline integrata con l'agenda.
- **Gestione team avanzata** — turni, presenze, calcolo delle competenze dei collaboratori sugli incassi effettivi.
- **Magazzino base + commercialista** — giacenze, soglie di riordino, lotti e scadenze; invio automatico dei dati contabili al commercialista.
- **Firma grafometrica** — firma su tablet dei consensi/documenti, archiviata col documento (già prevista tra le estensioni).
- **Codice UDI (impianti)** — tracciabilità del codice UDI dei dispositivi impiantabili — requisito per gli studi che fanno implantologia.

FASE 4 · Intelligenza e scala

AI e integrazioni — core + verticale

- **AI che scrive la cartella (dettatura)** — il professionista parla, la nota clinica si compila in tempo reale nella scheda paziente (verticale).
 - › **Nota privacy** — *è dato sanitario che esce verso l'AI. Costruibile e provabile con dati finti, ma NON in produzione su pazienti veri finché non è deciso “dove vanno i dati e con quali garanzie” (fornitore conforme, accordo di trattamento, validazione DPO).*
- **AI su imaging** — lettura degli elementi nelle immagini radiografiche a supporto della diagnosi e dell'accettazione (verticale odontoiatrico).
- **Previsione** — no-show, recall, fabbisogno di magazzino su agenda, cash flow.
 - › **Nota previsione no-show** — *privacy gestibile (dati comportamentali, non clinici; può girare sui dati interni). Ma PREMATURA finché non c'è uno storico di appuntamenti reali su cui prevedere.*

- **Integrazioni cliniche, FSE e scala** — scanner/sistemi radiologici ed export documenti FSE 2.0. Multi-sede completo, pagamenti online.

Riepilogo: cosa entra e quando

Legenda: [C] core trasversale (riusabile da future professioni) · [V] verticale clinico odontoiatrico. La colonna Privacy segnala i moduli con un nodo privacy da gestire.

Componente	Fase	Privacy
[C] Fondamenta tecniche + astrazione specialità	Fase 1	—
[C] Anagrafica paziente	Fase 1	—
[C] Consensi e privacy	Fase 1	—
[C] Agenda come hub centrale	Fase 1	—
[C] Fatturazione (Sistema TS, SdI)	Fase 1	—
[V] Cartella clinica + odontogramma	Fase 1	—
[V] Preventivi e piani di cura	Fase 1	—
[C] WhatsApp anti no-show + layout per ruolo	Fase 1	—
[C] Recall e reattivazione	Fase 2	—
[C] CRM multicanale + segmentazione	Fase 2	—
[C] AI per le comunicazioni	Fase 2	leggero
[C] Portale paziente + prenotazione online	Fase 2	—
[C] Dashboard KPI + marginalità	Fase 3	—
[C] Marketing e gestione lead	Fase 3	—
[C] Gestione team avanzata	Fase 3	—
[C] Magazzino base + commercialista	Fase 3	—
[C] Firma grafometrica	Fase 3	—
[V] Codice UDI (impianti)	Fase 3	—
[V] AI cartella (dettatura)	Fase 4	da decidere
[V] AI su imaging radiografico	Fase 4	da decidere
[C] Previsione no-show / recall / cash flow	Fase 4	prematura
[C/V] Integrazioni cliniche e FSE 2.0	Fase 4	—
[C] Multi-sede, pagamenti online	Fase 4	—

Nota sul nodo privacy delle funzioni AI

Le funzioni AI hanno pesi privacy diversi, perché dipende da quali dati escono verso il servizio AI esterno:

- **Generazione testi comunicazioni** — progettabile in modo che i dati identificativi NON escano (template all'AI, dati del paziente inseriti localmente). Nodo leggero: si può partire subito.

- **Dettatura cartella** — è dato sanitario che esce. Il nodo va deciso PRIMA della produzione con pazienti veri (fornitore conforme, accordo, DPO). Nel frattempo costruibile e provabile con dati finti.
- **Previsione no-show** — privacy gestibile (dati comportamentali, non necessariamente clinici), ma prematura per mancanza di storico su cui prevedere.

In ogni caso, ogni funzione AI in ambito sanitario resta assistiva: propone, l'operatore approva. Le scelte su basi giuridiche e fornitore AI vanno validate da un consulente privacy/DPO prima della produzione.

Documento di lavoro. La collocazione dei moduli è indicativa e va affinata con il cliente in base alle priorità reali dello studio; le scelte privacy sulle funzioni AI vanno validate con un consulente.